Unité d'Enseignement DF 4.2

Sémiologie et entités psychopathologiques

Livret d'accompagnement du CM

Licence 2 Psychologie

UPJV – Département de psychologie

PHILIPPE SPOLJAR

Courriel : philippe.spoljar@u-picardie.fr

Présentation

Objectifs

1. Acquérir les bases de la sémiologie psychopathologique

Identifier, nommer et définir les principaux signes et symptômes cliniques
Comprendre la distinction symptôme / signe / syndrome / tableau
Savoir organiser un tableau sémiologique

2. *Maîtriser la méthodologie de l'étude de cas*

Savoir repérer les éléments cliniques pertinents dans une observation
Regrouper les signes par grandes catégories fonctionnelles
Construire un tableau clinique argumenté
Formuler une hypothèse diagnostique

3. *Connaître les grandes entités psychopathologiques*

Névroses, psychoses, états dépressifs, troubles du comportement, perversions, etc.
Identifier leurs tableaux cliniques typiques
Comprendre leurs différences structurales

4. *Comprendre les différents modèles d'interprétation en psychopathologie*

Statut du symptôme selon les approches (psychanalytique, cognitive, systémique, biologique, phénoménologique)
Comprendre qu'un même signe peut recevoir des significations différentes selon le cadre théorique
Développer une réflexion critique sur les classifications contemporaines

5. *Introduire à l'étiologie et à la pathogénie (à partir de l'exemple des perversions)*

Mettre en relation les signes avec les mécanismes psychiques
Comprendre les logiques de formation des troubles
Préparer à une réflexion clinique approfondie en L3 et en Master

Manuels de référence

Pour vous aider : de nombreuses annexes et des références de manuels

Tribolet Serge, Shahidi Mazda, Nouveau précis de sémiologie des troubles psychiques, Paris, Éditions Heures de France, 2005.

Kapsambelis Vassilis (dir.), Manuel de psychiatrie clinique et psychopathologique de l'adulte, Paris, PUF, 2012.

Rabeyron Thomas, Psychologie clinique et psychopathologie, Paris, Armand Colin, 2018.

Pirlot Gérard, Classifications et nosologies des troubles psychiques : approches psychiatrique et psychanalytique, Paris, Armand Colin, 2013.

Évaluation

Pour les deux sessions, l'examen terminal (ETE) prend la forme d'un QCM de 20 questions, comportant chacune plusieurs propositions pouvant être vraies ou fausse

Barème de notation :
- aucune erreur = 1 point
- 1 erreur = 1/2 point
- plus d'une erreur = 0 point

Une partie des questions repose sur de courtes observations (semblables à celles étudiées en TD)

Sommaire

PRESENTATION

1. SIGNES ET SYMPTOMES

1.1. La structure théorique du symptôme
1.2. Le statut du symptôme dans les différentes psychopathologies
1.3. Méthodologie de l'étude de cas (Mme V., 40 ans)

2. LES PRINCIPAUX SIGNES CLINIQUES

2.1. La pensée
2.2. L'humeur et les affects
2.3. L'anxiété et l'angoisse
2.4. La perception
2.5. Le langage
2.6. La mémoire
2.7. L'intelligence
2.8. La conscience
2.9. L'activité psychomotrice
2.10. Les conduites

3. CATEGORIES ET STRUCTURES

3.1. Les classifications sémiologiques
3.2. Les entités psychopathologiques
3.3. Structure, personnalités et pathologies

4. LES PERVERSIONS SEXUELLES ET NARCISSIQUES

4.1. Clinique des perversions
4.2. Dynamique et développement pulsionnels
4.3. Les principales formes de perversions sexuelles
4.4. La perversion narcissique

TABLE DES MATIERES

1. Signes et symptômes

1.1. La structure théorique du symptôme

> *« Sur le plan sémiologique, l'examen psychiatrique est caractérisé par une multitude d'obstacles, de pièges, de difficultés en tous genres : des symptômes cachés par d'autres symptômes psychiques, des symptômes prenant le masque organique, l'expression bruyante de symptômes mineurs, la discrétion de symptômes majeurs, la possible réticence du patient, et l'absence de symptômes pathognomoniques. » (S. Tribolet, M. Shahidi,* Nouveau précis de sémiologie des troubles psychiques*, 2005, p. XVI).*

Définition de formes typiques de maladies, syndromes et structures, à partir :

- des symptômes et des signes (*sémiologie*)
- des causes (*étiologie*)
- des modes de formation (*pathogénie*)
- des significations

Point de départ : l'appréhension des symptômes

Cadre de l'analyse :

1/ Décrire (signe/symptôme/syndrome/tableau).

2/ Classer (nosographie/nosologie).

3/ Comprendre/interpréter

1.1.1. Du côté du sujet : les symptômes

> *« Le symptôme est un langage qu'il faut entendre » (S. Tribolet, M. Shahidi,* Nouveau précis de sémiologie des troubles psychiques*, 2005, p. XIX)*

Le symptôme est du côté du sujet, c'est ce dont il se plaint

C'est un phénomène complexe : le reflet extérieur d'un phénomène interne

Dans une approche compréhensive, le symptôme est considéré comme ce qui constitue la "demande" du sujet. Il faut examiner :

- le contenu symptomatique
- éventuellement les conditions de sa genèse
- les significations attribuées *par le patient* à ce qui fait symptôme
- la manière dont le symptôme se manifeste dans la vie du patient et son histoire
- les mots utilisés pour l'évoquer

Le symptôme cache et manifeste en même temps. Il s'agit donc de comprendre :

- le « message » dont il est porteur
- ses effets
- les raisons de son apparition

La dimension intersubjective est essentielle : le symptôme est « adressé »

1.1.2. Du côté de l'observateur : les signes et syndromes

> *« Si le diagnostic a un sens en psychiatrie, c'est avant tout, selon nous, comme aide pour mieux reconnaître, mieux voir, mieux entendre le signe que nous fait le patient dans sa souffrance. Un signe que le patient lui-même, le plus souvent, ne perçoit pas ou ne déchiffre pas. Ainsi le soin psychiatrique ne consiste pas à traiter un diagnostic mais à répondre à un symptôme ou une situation. »* (S. Tribolet, M. Shahidi, *Nouveau précis de sémiologie des troubles psychiques*, Editions Heures de France, 2005, p. XIX)

Le signe résulte de la transformation du symptôme, prenant place dans une sémiologie, dans le cadre d'une nosographie

Le travail sémiologique : traduire les symptômes en signes

Ambiguïté terminologique :

- soit : le symptôme est la part subjective du signe
- soit : les deux termes sont équivalents

1.1.3. Signe et sémiologie

Un signe n'existe jamais seul ; un signe isolé n'a aucune valeur diagnostique :

- seul un ensemble de signes a une signification
- les signes peuvent se manifester hors structure psychopathologique
- un même signe peut appartenir à plusieurs tableaux (cf. infra la question transnosographique)
- il n'y a pas de signes pathognomoniques

Étude sémiologique : recueil et organisation de l'ensemble des signes présents dans une situation clinique

Le travail d'analyse sémiologique consiste à caractériser des signes

L'absence d'un signe (ou l'absence d'une représentation dans le discours du patient) peut être importante

1.2. Le statut du symptôme dans les différentes psychopathologies

> *« il n'y a pas de faits, seulement des interprétations » (Friedrich Nietzsche,* Fragments posthumes *(n° 7), 1886).*

Le statut du signe varie selon les différentes orientations en psychopathologie.

1.2.1. Les « dys- »

La perspective de la variation autour de la norme :
- l' « hyper- » : en trop
- l' « hypo- » : en moins
- le « para- » : à côté

1.2.2. L'exemple de la phobie

Le statut de la phobie varie selon le modèle psychopathologique retenu :

- approche psychanalytique : la phobie comme déplacement symbolique
- approche systémique : la phobie comme symptôme d'une organisation familiale
- approche comportementale : la phobie comme mauvais conditionnement
- approche cognitiviste : la phobie comme distorsion cognitive et schéma dysfonctionnel
- approche psychiatrique/biologique : la phobie comme angoisse excessive à dissoudre
- approche phénoménologique : la phobie comme actualisation d'une angoisse existentielle

Synthèse générale (statut du symptôme) :

Orientation	Statut du symptôme	Sa situation / localisation	Traitement privilégié
Systémique	Expression d'un dysfonctionnement du système familial	Inscrit dans les interactions, communications et régulations familiales	Thérapie familiale, restructuration du système
Psychanalytique	Compromis psychique, symbole inconscient	Au croisement des conflits intrapsychiques, déplacement d'une angoisse plus profonde	Analyse, interprétation, mise à jour du sens inconscient
Comportementale	Erreur d'apprentissage, conditionnement inadapté	Observé comme un comportement isolé renforcé par l'évitement	Désensibilisation progressive, exposition graduée
Cognitiviste	Distorsion cognitive, activation de schémas dysfonctionnels	Dans les pensées automatiques, croyances, schémas de vulnérabilité ou danger	Restructuration cognitive, travail sur les schémas, exposition
Psychiatrique biologique	Réponse anxieuse excessive, dérèglement neurochimique	Dans les processus physiologiques et neurobiologiques	Médication anxiolytique, antidépresseurs
Phénoménologique	Modification du rapport vécu à soi, à autrui et au monde Actualisation d'une angoisse existentielle	Dans le mode d'être-au-monde, le vécu conscient du rapport à l'objet et au monde	Exploration du vécu, accompagnement existentiel, verbalisation de l'expérience

> Il n'existe donc ni neutralité, ni objectivité possibles. Une simple définition sélectionne :

- ce qui compte comme fait pertinent
- le niveau d'explication retenu

- le vocabulaire légitime

- et souvent déjà une théorie implicite du psychisme

1.3. Méthodologie de l'étude de cas (Mme V., 40 ans)

Premières phases d'une étude de cas (à partir d'une observation ou d'un entretien) :

1. Lecture/écoute linéaire et relevé sémiologique

2. Regroupement des signes par catégories

3. Proposition d'un diagnostic (psychiatrique)

Mme V., 40 ans, est hospitalisée en service de médecine, pour fatigue et amaigrissement. Les examens somatiques ne montrent aucune anomalie. Il est demandé au psychiatre de la rencontrer. Son discours est assez pauvre, monotone, le débit est lent. Elle se plaint de ne plus avoir de force, de n'avoir envie de rien, d'être oppressée : « *je ne dors plus, toutes les nuits je me réveille, pourtant je suis fatiguée, je ne fais rien, je ne suis capable de rien, je suis tout le temps triste* ». Elle dit elle-même qu'elle n'a plus faim, qu'elle pense ne pas pouvoir aller mieux et qu'elle se sent abandonnée. A plusieurs reprises, elle pleure au cours de l'entretien et dit qu'elle a peur de mourir. Le reste du temps, son visage exprime la tristesse. Il n'existe ni antécédents familiaux, ni antécédents personnels. *Aucun événement marquant* n'a pu être relevé dans les mois précédant l'apparition de son état qui dure depuis environ 5 semaines.

Le recueil et le regroupement des signes indiquent :

- *Troubles de l'humeur* :

Symptômes (données cliniques) >	Signes
"*elle ne pense pas pouvoir aller mieux*"	Pessimisme
"*je suis tout le temps triste*" ; "*son visage exprime la tristesse*"	Tristesse
"*elle pleure au cours de l'entretien*"	Pleurs
"*elle se plaint […] de n'avoir envie de rien*"	Perte des intérêts
"*je ne suis capable de rien*"	Idées d'incapacité, dévalorisation de soi

- *Activité psychomotrice* :

Symptômes (données cliniques) >	Signes
"*elle est hospitalisée pour fatigue*"	Fatigue
"*elle se plaint de ne plus avoir de forces*"	Asthénie
"*je ne fais rien*"	Apathie (?)
"son discours est assez pauvre, monotone", débit lent	Bradypsychie (?)

- *Troubles des conduites* :

Symptômes (données cliniques)	Signes
"*elle n'a pas faim*", amaigrissement	Anorexie
"*je ne dors plus, toutes les nuits je me réveille*"	Insomnies (milieu de nuit)

- *Peur et angoisse* :

Symptômes (données cliniques)	Signes
"*Elle se plaint […] d'être oppressée*"	Sentiment d'oppression
"*elle se sent abandonnée*"	Angoisse d'abandon
"*elle a peur de mourir*"	Angoisse de mort (idées suicidaires ?)
"*toutes les nuits je me réveille*"	Angoisses nocturnes, cauchemars ?

2. Les principaux signes cliniques

2.1. La pensée

a) Le jugement et le raisonnement

- le *rationalisme morbide* : raisonnements poussés jusqu'à l'absurde

- l'*incohérence* : illogisme, absurdité

b) Le cours de la pensée

- la *tachypsychie / fuite des idées* : accélération de tous les processus psychiques, notamment de la pensée.

- la *bradypsychie :* ralentissement de la pensée et mono-idéisme.

- les *troubles de la synthèse mentale* : difficulté à organiser la pensée et confusion mentale.

- la *discontinuité* de la pensée : interruption du cours de la pensée ("barrage"/"fading")

c) Le contenu de la pensée

- les *troubles imaginatifs :* expansion de l'activité imaginative (mythomanie, fabulation...)

- la *culpabilité pathologique*

- les *ruminations*

- les obsessions : représentations qui s'imposent au sujet qui reconnaît leur caractère pathologique

  . les obsessions *idéatives* : pensées obsédantes, compulsives

  . les obsessions *phobiques* : angoisses phobiques en l'absence de l'objet

  . les obsessions *impulsives :* peur de commettre un acte incontrôlé

- les *distorsions globales* de la pensée :

  . l'ambivalence *:* coexistence de tendances opposées

  . la pensée *autistique :* enfermement dans ses pensées

  . l'*hermétisme* : pensées opaques

  . la pensée *déréelle* : pensée sans ancrage dans la réalité

  . la pensée *magique :* croyance aux pouvoirs de la pensée sur la matière

  . la pensée *paralogique :* raisonnement d'apparence logique, dont les prémisses sont fausses

  . l'*automatisme mental* (syndrome de Clérambault) :

    - 1. syndrome d'influence : pensée imposée, entravée, contrôlée de l'extérieur

    - 2. hallucinations psychiques : voix intérieures, vol et devinement de pensée

d) Les idées délirantes

Conviction qui s'impose au sujet avec une force d'évidence particulière, souvent en opposition avec la réalité partagée ou le sens commun du groupe socio-culturel

1) Thèmes

- idées de *grandeur* (*mégalomanie*)
- idées d'*érotomanie*
- idées de *jalousie*
- idées de *persécution*
- idées de *quérulence*
- idées de *négation*
- idées d'*influence*
- idées de *référence*
- idées *mystiques*
- idées d'*indignité*
- idées de *filiation*

2) Mécanismes

- l'*intuition*
- l'*imagination*
- l'*illusion*
- l'*interprétation*
- l'*hallucination*

3) Degré de systématisation

- *systématisé* : développement ordonné, d'apparence "cohérente"
- *polymorphe* : multiplicité de thèmes et de mécanismes

4) Extension

- en *secteur* : ne concerne qu'un domaine circonscrit
- en *réseau* : extension graduelle à toute la vie du sujet

5) Acuité ou chronicité

- *aigu* : épisodes critiques
- *chronique* : présence permanente

6) Degré de conviction

Rapport du sujet à son délire : conviction, certitude ...

2.2. L'humeur et les affects

a) L'expression des émotions

- l'*hyperémotivité* : réaction émotionnelle excessive
- la *froideur affective / ataraxie* : absence d'expression
- la *labilité émotionnelle* : variabilité des manifestations émotionnelles
- l'*inhibition* : blocage ou affaiblissement d'une fonction psychique
- l'*alexithymie* : difficulté à identifier/exprimer ses émotions
- la *discordance* : inadéquation entre le discours et les émotions exprimées
- les *réactions* critiques : colère, crises, tension chronique ...

b) Les troubles de l'humeur

- la *dysthymie* : humeur dépressive
- l'*anhédonie* : perte de plaisir
- la *perte d'intérêt* (pour soi, pour le monde)
- le *sentiment d'absence d'avenir*
- le *sentiment d'incurabilité*
- les *idées suicidaires*
- l'*euphorie* : joie démesurée
- la *cyclothymie* : alternances brusques d'humeur, d'allure périodique

2.3. L'anxiété et l'angoisse

- l'*angoisse* : une sensation d'oppression et d'étouffement
- la *peur* : crainte devant un danger externe
- l'*anxiété* : appréhension d'un danger imminent
- l'*attaque de panique* : crise paroxystique d'angoisse
- l'*anticipation anxieuse*
- la *phobie* : angoisse suscitée par un objet ou une représentation spécifique
  - la *nosophobie* : crainte des contaminations
  - la *mysophobie :* peur d'être en contact avec la souillure
  - l'*agoraphobie :* crainte des espaces ouverts
  - la *claustrophobie :* crainte des espaces fermés
  - l'*acrophobie* : peur des hauteurs
  - la *sitiophobie :* peur d'être empoisonné par la nourriture
  - la *phagophobie* : crainte de s'étouffer en avalant
  - la *phobie scolaire* : aversion pour l'école

- la *phobie sociale* : peur du regard des autres

- la *dysmorphophobie :* crainte concernant une déformation physique

2.4. La perception

a) Les illusions

Déformation de la perception d'un objet réel

b) Les hallucinations

Perception d'objets qui n'existent pas dans la réalité extérieure

Les hallucinations psycho-sensorielles

- Les hallucinations *psycho-sensorielles* ont la qualité d'une perception normale : auditives, visuelles, olfactives, gustatives et tactiles

- Les hallucinations *cénesthésiques* concernent la sensibilité proprioceptive et intéroceptive

Les hallucinations psychiques

Les hallucinations *psychiques* correspondent au vécu d'une intrusion dans la vie psychique (cf. automatisme mental)

c) La conscience de soi

- le *trouble du schéma corporel* : illusions de déformations relatives au corps

- l'*altération de l'image du corps* : impression de changement de forme du corps

- le *signe du miroir* : examen long et fréquent de soi (essentiellement le visage) dans un miroir

- la *dépersonnalisation* : sentiment de désincarnation, de détachement de soi

2.5. Le langage

a) L'expression verbale

- le *mutisme* : absence de langage, intentionnelle ou non

- la *bradyphémie* : lenteur du rythme verbal

- la *logorrhée :* flot incoercible de paroles

- l'*écholalie* : répétition immédiate et fidèle des derniers mots de l'interlocuteur

- le *bégaiement* : difficulté d'expression portant sur le débit de la parole

- le *barrage :* brusque suspension du fil du discours

- les *impulsions verbales :* parasitage du discours, souvent par des jurons

- le *maniérisme :* mode d'expression emphatique

- la *schizophasie* : langage hermétique

b) La sémantique et la syntaxe

- le *néologisme* : création d'un mot nouveau n'ayant de sens que pour le sujet

- les *paralogismes (délirants)* : détournement du sens des mots ; énoncés faux d'apparence logique

- l'*agrammatisme* : expression télégraphique ou monosyllabique

c) La dyslexie

Difficulté d'apprentissage de la lecture

d) Les aphasies

Troubles du langage dus à des lésions cérébrales

2.6. La mémoire

a) Les amnésies

- l'amnésie *antérograde (de fixation)* : incapacité de fixer de nouveaux souvenirs

- l'*amnésie rétrograde (d'évocation)* : incapacité d'évoquer des souvenirs antérieurs au début de la maladie

- les *amnésies psychogènes/"affectives"* : amnésies électives, périodiques et post-traumatiques

- l'amnésie dissociative : incapacité à se remémorer des informations autobiographiques importantes

b) Les libérations mnésiques

- l'*hypermnésie* : flux de remémoration permanent ou paroxystique

c) Les paramnésies (illusions de mémoire)

- les illusions mnésiques ("*ecmnésie"*)

- le sentiment de "*déjà vu*", les fausses reconnaissances

- le *flashback* : souvenir intrusif d'un événement traumatique

2.7. L'intelligence

- l'*arriération* : limitation ou retard du développement intellectuel

- la *détérioration :* baisse de l'efficience intellectuelle (avec l'âge ou la maladie)

2.8. La conscience

a) La vigilance

Troubles quantitatifs de la vigilance :

- l'*hypervigilance* : très haut niveau de vigilance

- l'*hypovigilance* : très faible niveau de vigilance

- l'*obnubilation* : lenteur de la pensée et difficulté de compréhension

- l'*hébétude* : désintégration plus profonde

- le *coma* : perte complète de conscience

- la *désorientation temporo-spatiale* : perte des repères dans le temps et l'espace

Troubles qualitatifs de la vigilance :

- les *états oniroïdes* (ou *crépusculaires*) : monde proche du rêve
- l'*onirisme* : états de rêve pathologique
- la *déréalisation* : perte du caractère familier de l'environnement

b) L'attention et la concentration

Troubles de l'attention :

- l'*hyperprosexie* : augmentation de l'attention
- l'*hypoprosexie* : diminution de l'attention
- l'*aprosexie* : perte de la capacité attentionnelle

Troubles de la concentration :

- la distractibilité : incapacité à maintenir le fil d'une activité mentale
- la fatigue mentale : diminution rapide de l'effort psychique

2.9. L'activité psychomotrice

a) Les déficits

- le *ralentissement psychomoteur* : lenteur, fatigue, asthénie
- l'*apragmatisme* : incapacité à mener à bien une action finalisée
- la *stupeur* : état de sidération
- certaines *paralysies hystériques* (sans causes neurologiques) :
  . *astasie* : impossibilité de se tenir debout
  . *abasie* : impossibilité de marcher
- *aboulie* : absence ou diminution de la volonté

b) L'agitation

Formes / expressions motrices de l'excitation psychique :

- l'agitation *agressive*
- l'agitation *onirique*
- l'agitation *anxieuse*
- l'agitation *euphorique*
- l'agitation *discordante*
- l'agitation *théâtrale*
- la désinhibition

c) Les impulsions

- l'*impulsivité* : besoin impérieux d'accomplir soudainement un geste (brutal, dangereux, incongru...)

- le *raptus* : passage à l'acte clastique

- les *parakinésies* : mouvements anormaux parasites

- les *stéréotypies* : grattage, balancements, rotations, etc.

- les *tics :* mouvements involontaires de groupes de muscles en liaison fonctionnelle

d) Les apraxies

Les *apraxies* : impossibilité d'exécuter volontairement des mouvements orientés vers un but

2.10. Les conduites

a) La présentation

- les *inadaptations remarquables* (à l'âge, aux normes sociales...)

- le *maniérisme* : conduite affectée, désuète

- l'*incurie* : négligence extrême de soi

- la *clinophilie* : alitement permanent

b) Les mimiques

- les *hypermimies* : exagération des mimiques

- les *hypomimies* : réduction de l'expressivité du visage

c) Le sommeil

- les *insomnies* : manque ou mauvaise qualité du sommeil

- la *somnolence* (assoupissement diurne) et l'*hypersomnie* (besoin excessif de dormir)

d) L'alimentation

- les *restrictions alimentaires* : limitations volontaires

- la *dysphagie* : difficulté à déglutir ou à avaler

- l'hyporexie/*anorexie :* diminution ou perte d'appétit

- la *boulimie* : ingestion rapide et compulsive d'une quantité importante de nourriture, avec sentiment de perte de contrôle

- l'*hyperphagie* : prise d'aliments en quantités importantes

- la *potomanie* : ingestion de grandes quantités de liquide

- la *dipsomanie* : impulsion périodique à boire des boissons alcoolisées

e) Les sphincters

- l'*énurésie :* émission involontaire d'urine

- l'*encoprésie* : incontinence fécale

f) La sexualité

- l'*impuissance* : dysfonction érectile

- l'*éjaculation* précoce : délai très court entre pénétration et jouissance

- la *frigidité* : absence de plaisir

- la *dyspareunie :* douleurs lors des rapports sexuels

- le *vaginisme* : empêchement de toute pénétration

- l'*addiction sexuelle* : appétit sexuel insatiable et compulsif

g) Les rituels

- domaines : alimentation, sexualité, santé...

h) Les transgressions

- les *fugues* : fuite, souvent avec prise de risque

- la *kleptomanie* : vol pathologique

- les *perversions* sexuelles (fétichisme, masochisme, voyeurisme, exhibitionnisme, sadisme, zoophilie, ondinisme)

- le *suicide*, *tentative* ou *équivalents* : intention consciente ou inconsciente de mourir

- l'*homicide* : action de tuer, volontairement ou non, un autre être humain

3. Catégories et structures

3.1. Les classifications sémiologiques

3.1.1. Les catégorisations

La classification est un mode de pensée, sous-tendu par un raisonnement

Les classifications "a-théoriques" (DSM) reposent *de facto* sur des théories de la maladie mentale

3.1.2. Les syndromes

Le syndrome se constitue à partir d'une combinaison de signes

Un syndrome est un regroupement spécifique de signes, qui peuvent avoir plusieurs étiologies et se trouver dans plusieurs pathologies. Par exemple :

- syndrome de Cotard [humeur dépressive, négation d'organes] : mélancolie, schizophrénie, hypocondrie

3.1.3. Les tableaux cliniques

Un tableau clinique correspond à l'ensemble des signes présentés par un patient et peut constituer une variante clinique d'une entité pathologique

3.2. Les entités psychopathologiques

3.2.1. Nosographie et nosologie

Nosographie : description des maladies

Nosologie : doctrine de la maladie (logique, classification, étiologie)

Formes cliniques : tableaux sémiologiques distincts relevant d'une même entité

Une entité ou maladie correspond à une abstraction (schématisation d'une situation complexe)

Les entités psychopathologiques ont des définitions instables

La notion de "maladie mentale" : une médicalisation de la souffrance psychique

3.2.2. Les entités psychiatriques et psychopathologiques

3.2.2.1. Les regroupements traditionnels

Les entités psychiatriques sont traditionnellement regroupées dans les ensembles suivants :

1 - les *névroses*
- psychonévroses de défense (hystérie, névrose obsessionnelle, névrose phobique)
- névroses "actuelles" (névroses d'angoisse, neurasthénie, hypocondrie)

2 - les *psychoses*
- schizophrénies
- délires chroniques (paranoïa, psychoses hallucinatoires, paraphrénie)

- psychose maniaco-dépressive

- bouffées délirantes

3 - les *états dépressifs* (non psychotiques)
- dépression névrotique
- dépression réactionnelle

4 - les *démences*

5 - les *déficiences intellectuelles*

6 - les *troubles du comportement et du caractère*
- alcoolisme
- toxicomanie
- psychopathie...

7 - les troubles mentaux liés à une *affection organique*

- des confusions mentales
- des troubles liés aux tumeurs cérébrales, à l'alcoolisme, ou à des maladies neurologiques
- encéphalopathies

8 - les pathologies *psychosomatiques*

- asthme
- dermatoses (eczéma, psoriasis ...)
- hypertension
- ulcères gastriques...

Problèmes liés aux regroupements des entités : la pluralité de critères (forme, étiologie, évolution...)

9 - les pathologies « *fantômes* »

- "Trouble dépressif majeur"

- "Trouble anxieux social"

- "Addictions comportementales"

- Trouble déficitaire de l'Attention avec/sans Hyperactivité (TDAH)

Gonon François, *Neurosciences. Un discours néolibéral ? : Psychiatrie, éducation, inégalités*, Nîmes, Champ social éditions, 2024.

Gonon François, « La psychiatrie biologique : une bulle spéculative ? », *Esprit*, novembre 2011, p. 54-73.

- "Trouble anxieux généralisé" (TAG)

- "Trouble du spectre autistique" (TSA)

- "Trouble oppositionnel avec provocation" (TOP)

- "Trouble de stress post-traumatique" (TSPT)

- "Trouble de dérégulation disruptive de l'humeur" (DMDD)

3.2.2.2. La perspective psychodynamique

Une composition spécifique de critères structuraux et processuels :

- la structure

- le type de relation d'objet

- le mécanisme de défense primaire

- l'étiologie

La classification de J. Bergeret est composée à partir de quatre critères :

- la symptomatologie

- le type d'angoisse

- la relation d'objet

- les mécanismes de défense

Tableau des structures psychopathologiques, d'après Jean Bergeret, et al., *Psychologie pathologique*, Masson, 1982 :

	Symptômes	Type d'angoisse	Relation d'objet	Défenses
Psychoses	Dépersonnalisation Délire	Morcellement	Fusionnelle	Déni Clivage du moi Régression
Etat-limite	Dépression	Perte d'objet Abandon	Anaclitique	Clivage Défenses archaïques
Névroses	Obsessionnels, hystériques, phobiques...	Castration	Génitale	Refoulement Déplacement

3.2.2.3. La perspective neurophénoménologique

On envisage ici la manière dont le sujet habite son corps, son monde et ses relations avec autrui

Une perspective historiquement construite à partir de :

- la phénoménologie psychiatrique
- l'analyse existentielle

> prolongée par une approche « écologique » du cerveau (T. Fuchs)

Le trouble psychique concerne toujours :

- un sujet incarné

- situé dans un environnement

Le fonctionnement cérébral participe à ses relations avec le monde

La perspective neurophénoménologique croise :

- les signes cliniques observables

- la forme de l'expérience vécue

- le rapport au corps

- le rapport au temps

- le rapport à autrui et au monde

	Signes principaux	*Expérience vécue*	*Corps*	*Temps*	*Monde / autrui*
Mélancolie	Ralentissement, culpabilité, douleur morale, idées d'indignité	Perte d'élan vital, impossibilité d'exister autrement	Corps lourd, figé, épuisé	Avenir fermé	Monde vide, sans valeur
Schizophrénie	Dissociation, délire, hallucinations, dépersonnalisation	Perte de l'évidence de soi et du monde	Corps étrange, morcelé, désapproprié	Discontinuité, rupture	Monde menaçant, autrui intrusif
Phobie	Évitement, anxiété, attaque de panique	Monde organisé autour d'un danger localisé	Corps en alerte	Anticipation anxieuse	Monde rétréci par l'évitement

Fuchs Thomas, *L'écologie du cerveau. Phénoménologie et biologie de la cognition incarnée*, Bucarest, Zeta books, 2026.

(Fuchs Thomas, *Das Gehirn - ein Beziehungsorgan. Eine phänomenologisch-ökologische Konzeption*, Stuttgart, Kohlhammer, 6ème éd. augm. 2021).

3.3. Structure, personnalités et pathologies

3.3.1. La notion de structure

3.3.1.1. Définition générale

La définition d'entités psychopathologiques comme "l'ordre du désordre" :

> « *Les divers syndromes mentaux se répètent dans leurs grandes lignes, d'individu à individu, avec une régularité surprenante à première vue, comme s'ils étaient soumis à une loi, de sorte que les aliénés se laissent grouper plus facilement à première vue que les êtres normaux. Le nombre de syndromes est limité, les dégradations de structure semblent suivre des tracés préformés, toujours les mêmes.* Il y a de l'ordre dans le désordre. » (E. Minkowski, *Traité de psychopathologie*, 1966)

Origine de la notion de structure dans l'étude du langage

Un ensemble de "places" relatives les unes aux autres

Définition de la structure :

1 - il existe un *ordre symbolique* irréductible et antérieur à l'ordre du réel et de l'imaginaire

2 - les places désignées dans l'espace structural sont *premières* par rapport aux éléments

3 - les places occupées déterminent des *effets subjectifs*

4 - la structure est inconsciente

3.3.1.2. La structure psychique

L'organisation inconsciente du sujet

Le passage du niveau des manifestations (clinique) à celui des organisations (structure)

La métaphore du cristal, les "lignes de fragilité"

Une structure stabilisée est dite "*compensée*"

La *décompensation* s'effectue selon l'organisation (structurale) de la personnalité

Une cohérence essentielle existe entre situation normale et situation pathologique : la structure reste la même (qu'elle soit compensée ou décompensée)

3.3.2. Structure et personnalité pathologique

Personnalité : organisation dynamique des aspects intellectuels, affectifs et physiologiques de l'individu. Elle est une manifestation et une expression de la structure psychique

Personnalité pathologique / *organisation pathologique de la personnalité* : une déviation permanente d'un type de personnalité

Exemples de personnalités pathologiques et leurs évolutions (fréquentes mais *non systématiques*) :

- Personnalité obsessionnelle -> névrose obsessionnelle
- Personnalité hystérique -> névrose hystérique
- Personnalité schizoïde ou schizotypique -> schizophrénie
- Personnalité anxio-phobique -> névrose d'angoisse et phobique
- Personnalité limite -> état dépressif majeur

- Personnalité paranoïaque ou sensitive -> délires chroniques

Deux conceptions différentes des rapports entre "personnalité" et "entité pathologique"

4. Les perversions sexuelles et narcissiques

4.1. Clinique des perversions

Approfondissement des considérations précédentes :

- une sémiologie particulièrement fine
- des considérations étiologiques et pathogéniques spécifiques
- la "structure perverse", comme organisation psychique autonome
- une réflexion sur le statut de l'acte et du fantasme
- une interrogation sur la norme et la déviance
- des modalités particulières de la relation à l'autre

4.1.1. Critères et caractéristiques cliniques

La perversion se définit comme une conduite marquée par des « *déviations* » et « *transgressions* »

Une problématique difficile à situer entre science et morale

Le critère incertain de la *souffrance* mentale

L'organisation des classifications (Krafft-Ebing, *Psychopathia sexualis*, 1886) selon :

- leurs *objets* : pédophilie, gérontophilie, zoophilie
- leurs *moyens* / *buts* : sadisme, masochisme, fétichisme, voyeurisme, exhibitionnisme

Une position *descriptive* (et non *morale*, relativement aux "déviations"), qui repose sur les critères suivants :

- l'*exclusivité* du mode de satisfaction
- le *rabaissement* de l'objet libidinal

4.1.2. La « structure perverse »

Distinction entre *conduite* perverse et *organisation/structure* (mentale) perverse

Mécanismes pathogéniques centraux de la structure perverse : déni, clivage, fixation

4.1.3. Perspective différentielle

4.1.3.1. Fantasmes pervers et conduites perverses

Distinction indispensable entre la pensée et l'acte, pour éviter la confusion :

> *« L'absence de différence entre comportement et fantasme dans le DSM-IV ne permet plus de distinguer la névrose – avec le respect de la réalité de l'autre qu'elle implique – et la psychose ou la perversion. Les critères psychopathologiques et ceux du DSM sont donc en opposition sur ce point, même si la plupart des perversions sont repérées par les deux classifications »* (J.-L. Pédinielli, G. Pirlot, *Les perversions sexuelles et narcissiques*, Armand Colin, 2013, p. 30).

4.1.3.2. Perversion et perversité

Distinction également nécessaire entre :

- perversion sexuelle : conduites agies
- perversité : dimension morale, commune aux perversions sexuelles et narcissiques

4.2. Dynamique et développement pulsionnels

L' « ordre du désir » s'oppose au déterminisme instinctuel :

> *« La sexualité humaine, pulsionnelle, désirante et liée aux interdits et à la loi, est d'un autre ordre que celle, instinctuelle, de l'animal. Elle révèle, comme les perversions, un arrachement de l'ordre (humain) à l'ordre de la nature » (*J.-L. Pédinielli, G. Pirlot, *op. cit.*, p. 10).

Le désir est une expression pulsionnelle qui a subi un développement psychique et une mise en forme culturelle

4.2.1. Les caractéristiques de la sexualité infantile

S. Freud, *Trois essais sur la théorie sexuelle* (1905), Paris, Gallimard, coll. "Folio/Essais", 2001.

L'enfant « pervers polymorphe »

Traits spécifiques de la sexualité infantile :

- elle est "auto-érotique"
- elle se développe par étayage sur une fonction physiologique qui satisfait un besoin
- le plaisir obtenu est dispersé sur chaque partie ou fonction du corps (pulsion partielle)

Les pulsions partielles constituent l'origine et le modèle des perversions

Arrêts du développement et constitution de points de fixation

4.2.2. Névroses et perversions

La névrose est le négatif de la perversion

4.3. Les principales formes de perversions sexuelles

4.3.1. Le sadisme et le masochisme

4.3.1.1. Clinique

Définition du sadisme :

> *« Le sadisme consiste en des actes, souvent ritualisés, visant la douleur et/ou l'humiliation, voire la destruction de l' "objet" afin d'obtenir une satisfaction sexuelle. Il peut s'exprimer dans l'acte pervers, mais appartient aussi au fantasme et il est présent en chacun de nous, sans qu'il s'agisse de perversion. Des siècles de civilisation, l'éducation, nous ont contraints à le réprimer et à le refouler, voire à le sublimer » (J.-L. Pédinielli, G. Pirlot, Les perversions sexuelles et narcissiques, Armand Colin, 2013, p. 63).*

Définition du masochisme : l'humiliation et la domination par l'autre

> *« Le terme est un néologisme créé par Krafft-Ebing qui se réfère à l'écrivain Sacher-Masoch, auteur de la Vénus à la fourrure. Il décrit là l'obtention du plaisir sexuel par la recherche de sa propre soumission douloureuse et humiliante : les manifestations cliniques sont la quête de douleurs physiques, d'humiliations morales par une attitude servile de soumission à une femme (ou un homme), accompagnées de châtiments corporels jugés indispensables. » (J.-L. Pédinielli, G. Pirlot, Les perversions sexuelles et narcissiques, Armand Colin, 2013, p. 66).*

Les traits infantiles du masochisme

Masochisme « moral » :

- sentiment constant de souffrance
- recherche des vexations, du discrédit et de l'humiliation
- besoin de se mettre dans des situations d'échec
- besoin constant de se plaindre, ...

Auto-punition versus masochisme : la névrose obsessionnelle

4.3.1.2. Les destins pulsionnels

Deux "destins pulsionnels" impliqués dans la genèse des perversions :

- le renversement dans son contraire : de l'activité à la passivité
- le retournement sur la personne propre

Le renversement dans son contraire permet un changement de but :

- faire souffrir -> s'exposer à la souffrance
- voir -> être vu

Le renversement sur la personne propre procède à un changement d'objet :

- le masochisme est un sadisme envers le moi propre
- l'exhibitionnisme est un voyeurisme retourné sur son propre corps

Les quatre étapes de la transformation du sadisme en masochisme :

1. Exercice d'une violence active contre l'autre

2. Abandon de l'objet et remplacement par la personne propre

3. Transformation du but actif en but passif

4. Recherche d'un autre objet

Les quatre étapes de la transformation du voyeurisme en exhibitionnisme

1. Regard porté vers un objet externe

2. Retournement sur une partie du corps

3. Abandon de l'objet initial

4. Apparition d'un nouveau sujet auquel on se montre pour être regardé par lui

4.3.2. Le fétichisme

4.3.2.1. Clinique

Le fétichisme désigne cette nécessité de recourir à un objet (partie du corps ou objet matériel) pour pouvoir accéder à la satisfaction et à la jouissance.

Le fétiche est une métonymie du corps qui fonctionne ensuite comme métaphore

Guy de Maupassant, « La chevelure » (1884), Contes et nouvelles, t. II, Paris, Gallimard, "La Pléiade", 1979,

Jun'ichirō Tanizaki, « Le Pied de Fumiko » (1919), Œuvres, t. 1, Paris, Gallimard, "La Pléiade", 1997, p. 431-458.

Octave Mirbeau, Journal d'une femme de chambre (1900), Paris, Folio/Gallimard (adapté au cinéma par Luis Bunuel, 1964).

4.3.2.2. Le déni

L'objectivation de la croyance en un « organe phallique féminin »

La valeur symbolique du fétiche :

> *« Il [le prince] fit asseoir Cendrillon, et approchant la pantoufle de son petit pied, il vit qu'il y entrait sans peine, et qu'elle y était juste comme de cire » (Charles Perrault, « Cendrillon ou la Petite Pantoufle de Verre », Histoires ou Contes du temps passé, Editions Barbin, 1697).*

Une formation de compromis (comme le rêve ou le symptôme) :

. en tant qu'objet concret, le fétiche est tangible et visible

. en tant que symbole, il atteste (magiquement) de ce qu'il symbolise

Le fétiche accomplit ce par quoi il est maintenu : « supporter l'insupportable »

4.3.2.3. Le clivage du Moi

Le travail du déni consiste à maintenir deux éléments contradictoires, au prix d'une "déchirure" dans le Moi :

- reconnaître la réalité

- nier la réalité

Dynamique globale : angoisse > déni > clivage du Moi > maintien d'une fixation infantile (ou régression vers celle-ci)

4.3.3. Spécificités féminines

Des formes cliniques plus "plastiques" (cf. Catherine Millet, La vie sexuelle de Catherine M., 2001) :

- moins fréquemment organisées autour d'un objet fétichique matériel ;
- davantage investies dans le corps propre, la relation à autrui ou le lien narcissique ;
- parfois moins directement identifiables à partir de conduites sexuelles spécifiques.

4.3.3.1. Jouissance située dans l'emprise sur l'autre

- scénarios de domination affective ;
- manipulations relationnelles ;
- captation narcissique ;
- instrumentalisation de l'autre comme support de valorisation de soi.

Proximité avec certaines organisations de perversion narcissique :

- séduction ;
- instauration d'une dépendance ;
- dévalorisation et contrôle de l'autre.

4.3.3.2. Corps propre utilisé comme objet de mise en scène pulsionnelle

Le corps propre est investi comme objet d'une mise en scène pulsionnelle :

- objet de maîtrise ;
- objet de privation ;
- lieu d'une souffrance ou d'une humiliation ;
- et support d'une satisfaction pulsionnelle.

= une organisation sadomasochiste tournée vers soi-même

4.3.3.3. Dimension scopique du « corps phallique »

Le corps dans sa totalité peut fonctionner comme un équivalent phallique :

- exposé au regard de l'autre ;
- moyen de capter son désir ;
- maîtrise sur ce désir.

4.3.3.4. Perversité exercée dans les liens de dépendance : l'« incestuel »

Relations de dépendance, notamment au sein des relations familiales et maternantes :

- conduites d'emprise dans des relations fortement asymétriques ;
- érotisation de certains échanges ou soins corporels ;
- maintien d'une relation fusionnelle qui entrave la différenciation et l'autonomisation de l'enfant ;
- confusion des places et des limites entre les générations.

L'« incestuel » (P.-C. Racamier) : mode d'organisation relationnelle dans lequel les frontières psychiques et générationnelles sont compromises, et où l'emprise narcissique peut prendre une place déterminante

4.4. La perversion narcissique

L'autre est utilisé :

- comme support de valorisation narcissique
- ou comme objet de domination.

4.4.1. La dynamique narcissique

Déni de l'altérité sexuelle *versus* déni de l'altérité psychique

Une dépendance asymétrique

L'émergence de syndromes anxio-dépressifs et traumatiques

4.4.2. Les positions défensives

Angoisse d'abandon/de séparation

Défenses :

- déni
- clivage
- identification projective (mécanisme fantasmatique par lequel le sujet projette dans l'objet des parties de lui-même)

4.4.3. Les procédés du pervers narcissique

- des manoeuvres de communication
- une manipulation mentale
- des falsifications de la réalité
- une surestimation mensongère de soi-même et de sa pensée
- une dévalorisation de l'autre

Une « jouissance narcissique »

Table des matières

PRESENTATION

Objectifs
Manuels de référence
Évaluation
Sommaire

1. SIGNES ET SYMPTOMES

1.1. La structure théorique du symptôme
1.1.1. Du côté du sujet : les symptômes
1.1.2. Du côté de l'observateur : les signes et syndromes
1.1.3. Signe et sémiologie
1.2. Le statut du symptôme dans les différentes psychopathologies
1.2.1. Les « dys- »
1.2.2. L'exemple de la phobie
1.3. Méthodologie de l'étude de cas (Mme V., 40 ans)

2. LES PRINCIPAUX SIGNES CLINIQUES

2.1. La pensée
a) Le jugement et le raisonnement
b) Le cours de la pensée
c) Le contenu de la pensée
d) Les idées délirantes
1) Thèmes
2) Mécanismes
3) Degré de systématisation
4) Extension
5) Acuité ou chronicité
6) Degré de conviction
2.2. L'humeur et les affects
a) L'expression des émotions
b) Les troubles de l'humeur
2.3. L'anxiété et l'angoisse
2.4. La perception
a) Les illusions
b) Les hallucinations
Les hallucinations psycho-sensorielles
Les hallucinations psychiques
c) La conscience de soi
2.5. Le langage
a) L'expression verbale
b) La sémantique et la syntaxe
c) La dyslexie
d) Les aphasies
2.6. La mémoire
a) Les amnésies
b) Les libérations mnésiques
c) Les paramnésies (illusions de mémoire)
2.7. L'intelligence
2.8. La conscience
a) La vigilance
b) L'attention et la concentration
2.9. L'activité psychomotrice
a) Les déficits
b) L'agitation
c) Les impulsions
d) Les apraxies
2.10. Les conduites
a) La présentation
b) Les mimiques
c) Le sommeil
d) L'alimentation
e) Les sphincters
f) La sexualité
g) Les rituels
h) Les transgressions

3. CATEGORIES ET STRUCTURES

3.1. Les classifications sémiologiques
3.1.1. Les catégorisations
3.1.2. Les syndromes
3.1.3. Les tableaux cliniques
3.2. Les entités psychopathologiques
3.2.1. Nosographie et nosologie
3.2.2. Les entités psychiatriques et psychopathologiques
3.2.2.1. Les regroupements traditionnels
3.2.2.2. La perspective psychodynamique
3.2.2.3. La perspective neurophénoménologique
3.3. Structure, personnalités et pathologies
3.3.1. La notion de structure
3.3.1.1. Définition générale

3.3.1.2. La structure psychique

3.3.2. Structure et personnalité pathologique

4. LES PERVERSIONS SEXUELLES ET NARCISSIQUES

4.1. Clinique des perversions

4.1.1. Critères et caractéristiques cliniques

4.1.2. La « structure perverse »

4.1.3. Perspective différentielle

4.1.3.1. Fantasmes pervers et conduites perverses

4.1.3.2. Perversion et perversité

4.2. Dynamique et développement pulsionnels

4.2.1. Les caractéristiques de la sexualité infantile

4.2.2. Névroses et perversions

4.3. Les principales formes de perversions sexuelles

4.3.1. Le sadisme et le masochisme

98B4.3.1.1. Clinique

99B4.3.1.2. Les destins pulsionnels

4.3.2. Le fétichisme

4.3.2.1. Clinique

4.3.2.2. Le déni

4.3.2.3. Le clivage du Moi

4.3.3. Spécificités féminines

4.3.3.1. Jouissance située dans l'emprise sur l'autre

4.3.3.2. Corps propre utilisé comme objet de mise en scène pulsionnelle

4.3.3.3. Dimension scopique du « corps phallique »

4.3.3.4. Perversité exercée dans les liens de dépendance : l'« incestuel »

4.4. La perversion narcissique

4.4.1. La dynamique narcissique

4.4.2. Les positions défensives

4.4.3. Les procédés du pervers narcissique

TABLE DES MATIERES